EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92217
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-07 10:27:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA ELISA VENEGAS DIAZ			RUN	: 2.960.481-9
F.Nac	: 14-12-1931	Edad	: 92 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: NAVOTAVO 856			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-09-03	Fecha Egreso	: 2024-09-07 10:27:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. S06.5-HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-HIC occipital derecha, etiología obs amiloidea, ICH 1 (3.5 cc), 9° día evolución
-HSD tentorial derecha, etiología obs traumática
-Ant: HTA - mRS 1

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Ingreso
mRS 1, con antecedentes descritos, consulta en urgencias tras presentar hace 5 días caída en domicilio mientras lavaba su ropa, refiere sentirse mareada, resbalando con aguda, sufre caída con compromiso de conciencia, con reuperación espontánea (no logra aportar más detalles), debido a persistencia de mareos y cefalea consulta inicialmente en HCHM se realiza TC cerebro sc que muestra hematoma occipital derecho con mínimo HSC tentorial, evaluada por neurocx quien desestima manejo neurocx, se indica continuar manejo en HSC.
Evaluada en camillade urgencias, PAS 170, afebril, sin conflicto ventilatorio, normoglicémica, mantiene cefalea holocranea EVA 5/10, sin náuseas ni vómitos, al examen neurológico sin compromiso de CV, ni déficit focal.

Evolución
Paciente BEG, HDN con HTA moderada en control progresivo, RS al monitor, eupneica, afebril, tolera bien alimentación VO, no refiere molestias, tranquila y cooperadora.
Logró bipedestación y marcha con andador y asistencia de 1 operador, con buena tolerancia
Exs de lab de control sin hallazgos significativos.
AngioTC cerebro y cuello sin estenosis significativas (destaca placa mixta bulbo carotideo izquierdo) ni malformaciones vasculares. HIC occipital derecha sin cambios de volumen ni efecto de masa, de posible etiología amiloidea.
Diuresis(+) dep(-)
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio mañana sábado para continuar rehabilitación kinésica con HODOM, y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 15 días.

PLAN DE MANEJO:

-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica
-Control en policlínico de Neurología en 15 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Losartan 50 mg c/12 horas
2. -Amlodipino 10 mg/día
3. -Hidroclorotiazida 50 mg/día
4. -Carvedilol 25 mg 1/2 comp c/12 horas
5. -Trazodona 25 mg/noche si insomnio
6. -No usar aspirina u otro medicamento que afecte la coagulación

EXÁMENES Y RESULTADOS

5/9/24
-Leu 10800 Hb 11.9 Plaq 280000 Seg 74 VHS 43
-TTPA 25
-Alb 3.8
-Crea 0.9 MDRD 58.56 Uremia 44
-AU 4.5
-Na 138 K 3.7 Cl 104 Ca 9.6 P 3.6 Mg 2.1
-PCR 25.5
-RPR N/R
-OC N

3/9/24
-Crea 1 MDRD 51.86 Uremia 64
-PCR 14.1
-Na 139 K 4 Cl 105
-Leu 10200 Hb 11.4 Plaq 257000 Seg 71 VHS 27
-INR 1.03
-TSH 1.605 T4L 1.28
-B12 492
-Hb glic 5.5

29/8/24
-Crea 1 MDRD 51.86
-FA 76 BI 0.58 BD 0.32 BT 0.9 GOT 24 GPT 16 GGT 15
-Leu 9500 Hb 11.8 Plaq 259000 Seg 69 VHS 24
-INR 1
-TSH 2.02 T4L 1.01

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T ausculto soplos sistólicos 2/6 en los 4 focos
-Pulmonar: MP(+) SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos +/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, OTE, bradipsiquia e inatención leves, lenguaje N, distingue derecha-izquierda cruzando linea media
-PC: CV por amenaza impresiona hemianopsia izquierda, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, motilidad y sensibilidad faciales N, nistagmo(-), pares bajos N
-Motor: PPP(-), RCP flexor bilateral, hipotonía BC izquierda
-Sensibilidad: impresiona conservada en las 4 EE
-Cerebelo: conservado
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO